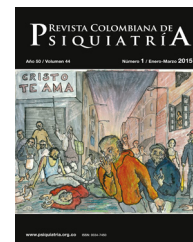


REVISTA COLOMBIANA DE
PSIQUIATRÍAwww.elsevier.es/rcp

Artículo original

Trastorno afectivo bipolar y trastorno por uso de sustancias. Prevalencia y factores asociados a la patología dual en población general de Colombia☆

Susana Arroyave Bustamante^a, Valentina López Gómez^a, Sara Montoya González^a, Melissa Sierra Restrepo^a, Valentina Solarte Góngora^a, Isabella Trujillo Duque^a, Daniel Vásquez Botero^b, Gloria María Sierra Hincapié^c, Diana Restrepo^{d,*}
y Finalmente, queremos agradecer a la población de estudio por su colaboración

^a Estudiante de pregrado de Medicina, Universidad CES, Medellín, Colombia

^b Residente de Psiquiatría, Universidad CES, Medellín, Colombia

^c Magíster en Epidemiología, Universidad CES, Medellín, Colombia

^d Psiquiatra de Enlace, Universidad CES, Medellín, Colombia

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 28 de agosto de 2023

Aceptado el 3 de marzo de 2024

On-line el xxx

Palabras clave:

Patología dual

Trastorno afectivo bipolar

Prevalencia

Alcohol

Drogas

RESUMEN

Introducción: La comorbilidad entre el trastorno afectivo bipolar (TAB) y el trastorno por uso de sustancias (TUS) es relevante en el contexto de la patología dual por la alta prevalencia y las implicaciones clínicas y sociales. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia del TAB comórbido con el TUS y los factores sociodemográficos y clínicos asociados en la población general.

Metodología: Estudio transversal analítico, con fuente de información secundaria de estudio poblacional con 2.072 participantes de 15 a 65 años entrevistados con el *Composite International Diagnosis Interview* (CIDI) versión 3.0; se diagnosticaron 23 trastornos mentales según criterios del *Diagnostic and Statistical Method IV* (DSM-IV). Se incluyeron variables sociodemográficas y clínicas psiquiátricas.

Resultados: Las prevalencias de vida para la comorbilidad TAB y alcohol (abuso 7,4%, dependencia 9,7%); TAB y drogas (abuso 6,5%, dependencia 18,8%) y TAB y TUS (incluido alcohol y drogas) 12,2%. Luego de ajustar por variables clínicas y sociodemográficas en el modelo multivariado permanecieron abuso de alcohol (RPa 6,60, intervalo de confianza [IC] 95% [1,54-28,26]), dependencia a drogas (RPa 6,16, IC95% [1,38-27,45]), trastorno oposicionista desafiante (RPa 7,39, IC95% [2,40-22,72]) y maltrato físico (RPa 2,58 [1,01, 6,58]).

Discusión: En el subgrupo de personas con TAB, luego de controlar factores de confusión como trastornos mentales y variables sociodemográficas, se observó una fuerte asociación con dependencia a drogas y abuso de alcohol. Emergen dos factores de riesgo adicionales, el maltrato físico en la niñez y el trastorno oposicionista desafiante que han sido previamente asociados con desenlaces desfavorables en la salud mental.

☆ Los autores declaramos que el artículo es original y que todos hemos contribuido sustancialmente en él.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: drestrepob@ces.edu.co (D. Restrepo).

<https://doi.org/10.1016/j.rcp.2024.03.003>

0034-7450/© 2024 Asociación Colombiana de Psiquiatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Conclusiones: La detección de cohortes específicas en riesgo de sufrir un trastorno mental es un desafío. Este estudio encontró que las personas diagnosticadas con TAB a lo largo de la vida, son más vulnerables que otros a tener un TUS.

© 2024 Asociación Colombiana de Psiquiatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Bipolar Affective Disorder and Substance Use Disorder. Prevalence and Factors Associated with Dual Pathology in the General Population of Colombia

ABSTRACT

Keywords:

- Dual diagnosis
- Bipolar disorder
- Prevalence
- Alcohol
- Drugs

Introduction: Comorbidity between bipolar disorder (BD) and substance use disorder is relevant in the context of dual pathology due to its high prevalence and clinical and social implications. The objective of the study was to determine the prevalence of comorbid bipolar affective disorder with substance use disorder and associated sociodemographic and clinical factors in the general population.

Methodology: Analytical cross-sectional study, with a secondary source of information from a population study with 2,072 participants from 15 to 65 years of age interviewed with CIDI 3.0 (Composite International Diagnosis Interview); 23 mental disorders were diagnosed according to DSM-IV criteria. Sociodemographic and psychiatric clinical variables were included.

Results: Lifetime prevalence of BD and alcohol comorbidity (abuse 7.4%, dependence 9.7%); BD and drugs (abuse 6.5%, dependence 18.8%) and substance use disorder (including alcohol and drugs) 12.2%. After adjusting for clinical and sociodemographic variables in the multivariate model, alcohol abuse [RPa 6.60, 95%CI (1.54-28.26)], drug dependence [RPa 6.16, CI95% (1.38 -27.45)], oppositional defiant disorder [RPa 7.39, 95% CI (2.40-22.72)], and physical abuse [RPa 2.58 (1.01-6.58)].

Discussion: In the subgroup of people with BD, after controlling for confounding factors such as mental disorders and sociodemographic variables, a strong association with drug dependence and alcohol abuse was observed. Two additional risk factors emerge, childhood physical abuse and oppositional defiant disorder, which have previously been associated with poor mental health outcomes.

Conclusions: Detection of specific cohorts at risk of mental disorder is challenging. This study found that people diagnosed with BD throughout life are more vulnerable than others to having a substance use disorder.

© 2024 Asociación Colombiana de Psiquiatría. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

El trastorno afectivo bipolar (TAB) es un trastorno crónico, recurrente con alta heredabilidad y comorbilidad con otros trastornos mentales y médicos¹. Se caracteriza por fluctuaciones en el estado del ánimo y la energía. El TAB I afecta a 1,1% y el TAB II al 1,2% de la población general².

El TAB se asocia con un mayor riesgo de consumo de sustancias^{3,4}, mayor mortalidad por suicidio y enfermedad cardiovascular⁵, así como una pérdida potencial de 10 a 20 años de vida y una significativa reducción en el funcionamiento psicosocial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el TAB ocupa el sexto puesto entre las diez primeras causas de discapacidad por enfermedad, constituyendo una de las enfermedades mentales con mayores repercusiones personales, familiares, económicas y sanitarias^{6,7}.

En cuanto al trastorno por uso de sustancias, su principal característica son los síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo continúa usando la sustancia a pesar de problemas significativos relacionados con ella⁸. Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe aproximadamente 5,6 millones de personas presentan algún trastorno por abuso de sustancias⁹⁻¹¹.

La patología dual se ha definido como la presencia de un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias (TUS) simultáneamente. Esta concurrencia determina peores desenlaces clínicos, mayor gravedad sintomática, mayor número de recaídas, mayor resistencia al tratamiento, mayor comportamiento suicida, peor funcionamiento cognitivo y menor adherencia a los tratamientos^{12,13}.

En pacientes con TAB la comorbilidad con alcohol y drogas se ha descrito tan frecuente como en 50% de los casos¹⁴

y en pacientes con TUS se observa una mayor prevalencia de episodios de manía e hipomanía (3,7 a 13,4%) comparado con la población general¹⁵. Por tanto, la relación entre el TAB y el TUS es bidireccional. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre ambos trastornos, así como los factores socio-demográficos y clínicos psiquiátricos asociados en población general de Envigado, Colombia.

Métodos

Tipo de estudio

Estudio observacional descriptivo, de prevalencia, con intención analítica a partir de fuente de información secundaria¹⁶. El grupo de referencia estuvo constituido por población general no institucionalizada de 15 a 65 años de ambos sexos, con hogar fijo, en zonas urbana y rural del municipio de Envigado, Colombia. No se contó con criterios de exclusión. El muestreo primario fue probabilístico y polietápico, calculado a partir de una proporción poblacional con un nivel de confianza de 95%, precisión de 5% y prevalencia estimada de 9,95% (prevalencia de vida esperada para depresión mayor según resultados del Primer Estudio de Salud Mental, Medellín 2011-2012)¹⁶.

Se encuestó a 2,072 personas. La composición de la muestra fue proporcional a la composición del universo desde el punto de vista geográfico y socioeconómico, por tal razón el diseño fue con probabilidad de selección igual hasta el nivel del hogar. Se sensibilizó a la comunidad antes de la aplicación de la encuesta mediante volantes, líneas telefónicas y canales regionales informativos. Se incluyeron las siguientes variables: edad, sexo, trastornos de ansiedad (pánico, ansiedad generalizada, agorafobia, separación, fobia simple, fobia social, estrés postraumático, obsesivo compulsivo), trastornos afectivos (depresión, bipolar), trastornos del neurodesarrollo (conducta, déficit de atención e hiperactividad, opositorista desafiante), maltrato físico en la niñez y negligencia en la niñez, TUS (abuso y dependencia de alcohol y de drogas), y comportamiento suicida (ideas, planes, intentos).

El instrumento de recolección aplicado fue el *Compositum International, Diagnosis Interview* (CIDI) versión 3.0, una entrevista psiquiátrica estructurada que aplica criterios del *Diagnostic and Statistical Method IV* (DSM-IV), para realizar el diagnóstico de 23 trastornos psiquiátricos. La versión utilizada en el estudio fue validada cultural y lingüísticamente en el Primer Estudio de Salud Mental Medellín, 2011-2012¹⁶. La entrevista se realiza cara a cara, aplicada por 10 entrevistadores legos (sin formación en áreas de salud mental), capacitados según el protocolo Harvard-OMS para la aplicación de la entrevista sin inducir respuestas.

La entrevista se aplicó en dos partes. La primera al total de las personas seleccionadas para tamizar y, en el caso de respuestas positivas para la presencia de algún trastorno mental, se realizaba la segunda parte que hace diagnósticos de trastornos mentales. Sin embargo de las personas que dieron negativo en la primera parte de la entrevista fueron seleccionadas aleatoriamente por el software de cada encuestador entre 30 y 60% y se les realizó también la parte II de la entrevista. El tiempo promedio de la entrevista completa fue de dos horas, lo cual en algunos casos requirió que esta se realizara

en dos etapas para evitar errores por fatiga, tanto en el entrevistado como el entrevistador. El tiempo se relacionó con la frecuencia de trastornos mentales presentes en el entrevistado.

El estudio primario controló el sesgo de selección mediante el muestreo probabilístico y el sesgo de información mediante la sensibilización a la comunidad (participación de 90% de las personas seleccionadas), el entrenamiento de los encuestadores, el control de calidad al tiempo de las entrevistas y la verificación de la información a 10% de los datos recogidos mediante llamada telefónica. El sesgo de confusión se controló en este estudio mediante la inclusión de variables potencialmente confusoras y el análisis multivariado.

Análisis de la información

El procesamiento de datos se realizó mediante el programa SPSS versión 24.0, licencia amparada. La base de datos fue sometida a controles de calidad. Con las variables sometidas a factores de corrección y expansión se estimaron proporciones de prevalencia de vida para los trastornos mentales y otras variables de interés. Las variables cualitativas se expresaron mediante frecuencias absolutas y relativas.

La comparación entre los dos grupos se realizó mediante la prueba de chi-cuadrado (X^2) o el test exacto de Fischer. Todos los datos fueron analizados teniendo en cuenta un nivel de significancia de 5%. Se calculó la razón de prevalencia cruda con su IC 95%. Para evaluar los factores que pudieron influir en la presencia de la variable dependiente (TAB), se aplicó un modelo multivariado de regresión logística binario de tipo explicativo donde se incluyeron las variables que en el modelo bivariado alcanzaron una $p < 0,1$ y como criterio de salida se estableció $p < 0,05$.

El proyecto fue aprobado por el Comité De Investigación Universitario. El estudio primario contó con la aprobación del Comité de Ética y tomó consentimiento informado a los adultos y a los menores de edad asentimiento y consentimiento al padre o tutor legal.

Resultados

Se incluyó la información de 2.072 encuestas, de las cuales 46,7% fueron aplicadas a personas del sexo masculino; el nivel de escolaridad más frecuente fue secundaria con 51% (ningún nivel de escolaridad 0,3%, primaria 9,0%, secundaria 51%, técnica-tecnológica 16,6%, universitario 13,2% y posgrado 9,8%). En la figura 1 se puede observar la distribución según edad y sexo.

Prevalencia del trastorno afectivo bipolar y el trastorno por uso de sustancias

La prevalencia de vida para el TAB fue de 1,17% con un IC de 95% entre 0,7 y 1,6% y un predominio de hombres sobre mujeres, 1,41 vs. 0,96% respectivamente. La prevalencia de vida para el abuso y la dependencia de alcohol y drogas fue mayor para los hombres en comparación con las mujeres: abuso de alcohol 13,47% (22,9 vs. 6,6%); dependencia de alcohol 3,8% (6,3

Tabla 1 – Análisis bivariado: trastorno por uso de sustancias * y trastorno afectivo bipolar

Sustancia	Trastorno afectivo bipolar		RP	IC 95%		Valor p
	Sí (%)	No (%)		LI	LS	
Abuso de alcohol						
Sí	7,4	92,6	3,71	1,49	9,19	0,009
No	0,9	99,1				
Dependencia de alcohol						
Sí	9,7	90,3	4,35	1,22	15,44	0,045
No	2,4	97,6				
Abuso de drogas						
Sí	6,5	93,5	2,78	0,79	9,69	0,118
No	2,4	97,6				
Dependencia a drogas						
Sí	18,8	81,3	9,53	2,52	35,99	0,007
No	2,4	97,6				
Dependencia a cualquier sustancia						
Sí	12,2	87,8	6,17	2,18	17,47	0,003
No	2,2	97,3				
Abuso a cualquier sustancia						
Sí	6,7	93,3	3,43	1,43	8,20	0,009
No	2,0	98,0				
Cualquier trastorno por sustancias						
Sí	6,5	93,5	3,33	1,39	7,95	0,01
No	2,0	98,0				

IC: intervalo de confianza; LI: límite inferior; LS: límite superior; RP: razón de prevalencia.

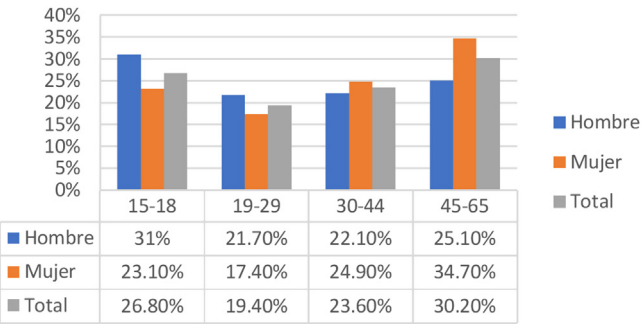


Figura 1 – Distribución porcentual según edad y sexo de la población de estudio.

vs. 2,1%); abuso de drogas 4,9% (10,3 vs. 1,1%); y dependencia de drogas 1,45% (2,4 vs. 0,7%) respectivamente [tabla 1](#).

Prevalencias de patología dual: trastorno afectivo bipolar y trastorno por uso de alcohol y drogas

La prevalencia de vida para el TAB comórbido con los trastornos por uso de alcohol y drogas, se presentan en la [tabla 1](#). La mayor prevalencia se observó entre TAB y dependencia a drogas con 18,8%, seguido por TAB y dependencia a alcohol con 9,7% [tabla 1](#).

Análisis bivariado

Se buscaron posibles asociaciones entre TAB y TUS. En la [tabla 1](#), se muestra el cruce de variables. Se encontró asociación significativa con abuso de alcohol, dependencia de alcohol y dependencia a drogas. No se encontró asociación

con abuso de drogas. La asociación más fuerte se encontró con dependencia a drogas [tabla 1](#).

Además, se exploraron posibles asociaciones del TAB con otras variables incluidas en el estudio. Se encontró asociación entre TAB y diferentes trastornos de ansiedad, trastornos de inicio en la niñez y comportamiento suicida ([tabla 2](#)).

Análisis multivariado

Se realizó un modelo de regresión logística binario de tipo explicativo (método forward), de la presencia de TAB ([tabla 3](#)). El modelo se ajustó por las siguientes variables: pánico, agorafobia, fobia social, obsesivo compulsivo, abuso de alcohol, dependencia al alcohol, abuso de drogas, dependencia a drogas, comportamiento suicida, maltrato físico en la niñez, opositorista desafiante, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastorno de conducta. El modelo fue significativo y explicó entre 0,034 y 0,156 y clasificó correctamente 97,5% de los casos. Permanecieron en el modelo las siguientes variables: abuso de alcohol, dependencia a drogas, trastorno opositorista desafiante y maltrato físico en la niñez ([tabla 3](#)).

Discusión

Este estudio buscó determinar la prevalencia de la patología dual (TAB y sustancias) en población general de 15 a 65 años. Además de encontrar elevadas prevalencias de vida para el TAB comórbido con sustancias, se identificaron asociaciones significativas con otros trastornos mentales.

Un estudio danés que incluyó a 463.000 pacientes encontró una prevalencia de vida para TUS en pacientes bipolares de 25,0%¹⁷, lo cual es superior a nuestro hallazgo de trastorno por

Tabla 2 – Análisis bivariado: trastorno afectivo bipolar * otras variables incluidas en el estudio

	Trastorno afectivo bipolar		RP	IC 95%		Valor p
	Sí (%)	No (%)		LI	LS	
Sexo						
Masculino	1,4	98,6	1,56	0,70	3,50	0,2739
Femenino	0,9	99,1				
Grupo etario						
Adolescentes	1,4	98,6	1,37	0,59	3,18	0,4663
Adultos	1,1	98,9				
Área de residencia						
Urbana	1,4	98,6	5,86	0,79	43,30	0,0479
Rural	0,2	99,8				
Trastorno de pánico						
Sí	13,6	86,4	13,31	4,28	41,39	0,0000
No	1,0	99,0				
Ansiedad generalizada						
Sí	5,6	94,4	4,96	0,71	34,79	0,0799
No	1,1	98,9				
Agorafobia						
Sí	20,0	80,0	17,97	2,97	108,69	0,0001
No	1,1	98,9				
Fobia social						
Sí	10,4	89,6	11,10	4,32	28,48	< 0,0001
No	0,9	99,1				
Fobia específica						
Sí	7,7	92,3	8,96	3,81	21,07	< 0,0001
No	0,9	99,1				
Estrés postraumático						
Sí	3,8	96,2	3,42	0,48	24,40	0,1974
No	1,1	98,9				
Ansiedad por separación						
Sí	17,6	82,4	17,27	5,68	52,48	< 0,0001
No	1,0	99,0				
Obsesivo compulsivo						
Sí	12,5	87,5	11,22	1,72	73,36	0,0027
No	1,1	98,9				
Comportamiento suicida						
Sí	4,2	95,8	5,50	2,47	12,25	< 0,0001
No	0,8	99,2				
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad						
Sí	9,7	90,3	4,03	1,27	12,79	0,0132
No	2,4	97,6				
Trastorno de conducta						
Sí	30,8	69,2	13,72	5,45	34,55	< 0,0001
No	2,2	97,8				
Trastorno oposicionista desafiante						
Sí	18,8	81,3	9,09	3,87	21,36	< 0,0001
No	2,1	97,9				
Maltrato físico en la niñez						
Sí	7,7	92,3	4,26	1,93	9,38	0,0001
No	1,8	98,2				
Negligencia en la niñez						
Sí	11,1	88,9	4,33	0,65	28,69	0,1124
No	2,6	97,4				

IC: intervalo de confianza; LI: límite inferior del intervalo de confianza; LS: límite superior del intervalo de confianza; RP: razón de prevalencia.

uso de cualquier sustancia de 6,5%. El estudio *National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions* (NESARC)^{18,19}, el cual incluyó a 43.093 participantes, no encontró asociación entre TAB y abuso de alcohol (*odds ratio* [OR] 1,0 IC95% [0,77-1,32]) pero sí lo encontró con dependencia a alcohol (OR 4,7 IC95% [3,72-5,79]), lo cual difiere con nuestros hallazgos.

Un metaanálisis que exploró la comorbilidad entre TAB y TUS, el cual incluyó a 218.397 individuos, encontró asociación entre TAB y sustancias (OR 4,96; IC 3,98-6,17)²⁰. Nuestro estudio mostró una asociación más fuerte entre TAB y dependencia a drogas que la encontrada entre TAB y abuso de drogas (RP 18,8 vs. RP 6,5, respectivamente).

Tabla 3 – Modelo de regresión logística binario explicativo para trastorno afectivo bipolar

Variable	Coefficiente β	OR ajustado	IC95%	Valor de p
Abuso de alcohol	1,888	6,60	1,54 - 28,26	0,01
Dependencia de drogas	1,819	6,16	1,38 - 27,45	0,01
Oposicionista desafiante	2,001	7,39	2,40 - 22,72	0,01
Maltrato físico	0,948	2,58	1,01 - 6,58	0,04

IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio.

Otros estudios con muestras de pacientes han identificado altas prevalencias de vida para TAB y TUS (54 a 72%)²¹⁻²³, así como en personas con adicciones que buscan tratamiento hospitalario, se ha reportado una alta prevalencia para TAB (21,7%)^{24,25}.

El perfil sociodemográfico encontrado por nosotros coincide con el reportado en otros estudios, en el cual predomina el sexo masculino y jóvenes, pero en nuestro caso sin asociación estadística²⁶. Tanto el alcohol como las drogas, especialmente la cocaína, han sido consideradas sustancias que pueden inducir estados afectivos patológicos y se ha descrito un mayor consumo de estas sustancias durante la fase de exaltación afectiva y desinhibición que acompaña la manía²⁷.

Trastorno afectivo bipolar comórbido con otros trastornos mentales

El TAB es un problema de salud mental frecuentemente asociado con otros trastornos mentales. Algunas investigaciones han mostrado que, a lo largo de la vida, 92% de las personas que sufren de TAB reportan haber sufrido de por lo menos otro trastorno mental²⁸. Si bien la ansiedad es bastante prevalente en personas con TAB afectando negativamente el curso de la enfermedad y su calidad de vida, este es un tema poco investigado hasta el momento²⁹. Los trastornos de ansiedad son los trastornos psicológicos más frecuentemente comórbidos en pacientes bipolares en la población general³⁰, con una prevalencia de vida que oscila en un rango de 32 a 88%³¹ y cerca de un tercio de ellos pueden estar afectados por un trastorno de ansiedad en cualquier momento. En nuestro estudio se encontró asociación en el modelo bivariado entre TAB y algunos trastornos de ansiedad. Spoorthy et al.³², encuentran comorbilidad entre TAB y todos los trastornos de ansiedad, con prevalencias cercanas a 20% para pánico, ansiedad generalizada y fobia social, y menores para ansiedad social, fobia específica y agorafobia. En nuestro estudio se encontró la mayor prevalencia con agorafobia y ansiedad por separación.

El TDAH ha sido identificado como uno de los problemas mentales con mayor comorbilidad con TAB. En un metaanálisis de 71 estudios con 646.766 participantes de 18 países, se encontró que uno de cada 13 adultos con TDAH tenía TAB (7,9% IC 5,31-11,06%) y uno de cada seis adultos con TAB tenía TDAH (17,1%, IC 13,0-21,6%)³³. En nuestro estudio, el TDAH fue tres veces más frecuente en los pacientes con TAB.

En cuanto a la comorbilidad entre TAB y trastorno de conducta, nuestro estudio encontró que un tercio de las personas con TAB reportaron el antecedente en la niñez de trastorno de conducta, lo cual ha sido reportado en estudios clínicos y epidemiológicos^{34,35}, sin embargo, la forma como estos dos trastornos se relacionan es motivo de controversia e investi-

gación. El estudio de Wozniak et al.³⁶ concluyó que el TAB-I es frecuentemente comórbido con trastorno de conducta y que el estudio de cosegregación es consistente con la hipótesis de que la comorbilidad representa un subtipo de los dos trastornos. Sin embargo, en nuestro estudio se encontró alta colinealidad en el modelo de regresión logística que exigió el retiro de la variable.

Trastorno afectivo bipolar y maltrato infantil

El abuso físico o sexual en la niñez ha sido descrito como un factor que empeora el curso del TAB. En una revisión sistemática reciente, la cual incluyó 39 estudios, se encontró una asociación significativa entre exposición en la niñez a situaciones traumáticas, como el abuso físico, y trastornos mentales en la adultez con un rango de riesgo entre OR 1,24 y 2,9³⁷. Mejorar el impacto del abuso físico en el desarrollo del trastorno bipolar parece ser un objetivo importante de la terapia, así como intentar prevención primaria y secundaria. Los tratamientos basados en la familia que se centran en la psicoeducación, la mejora de la comunicación intrafamiliar y las habilidades de afrontamiento pueden ser particularmente útiles³⁸.

Comportamiento suicida

El TAB tiene una de las tasas de suicidio más altas de todos los trastornos mentales y es aproximadamente de 20 a 30 veces mayor que en la población general. En cuanto al comportamiento suicida, nuestros datos indican que este subgrupo de pacientes con TAB y TUS tienen un mayor riesgo, lo cual ya ha sido previamente descrito³⁹. En muestras clínicas, 14 a 59% de los pacientes tienen ideación suicida y 25 a 56% presentan por lo menos un intento de suicidio a lo largo de la vida⁴⁰. Las causas del comportamiento suicida son múltiples y complejas. Algunos de los más fuertes predictores de este comportamiento identificados en la literatura son el estado afectivo, la gravedad de la depresión, la ansiedad comórbida, la agresividad, hostilidad, desesperanza y la comorbilidad con otros trastornos mentales, historia de estados mixtos y antecedente de abuso físico o sexual⁴¹. Nuestro estudio encontró en el modelo bivariado numerosas asociaciones del TAB con otros trastornos mentales pero, al ajustar por factores de confusión, el comportamiento suicida quedó fuera del modelo ajustado.

Limitaciones

Algunas limitaciones del estudio: primero, por tratarse de un estudio transversal no se pueden inferir relaciones causales;

segundo, las prevalencias de las sustancias se tomaron de forma agrupada, por lo tanto no se pueden extraer conclusiones sobre el efecto de una droga en concreto; tercero, al tratarse de una muestra poblacional no se pueden extrapolar los resultados a poblaciones clínicas; y cuarto, los diagnósticos del CIDI 3.0 son con base en criterios DSM-IV y CIE-10, los cuales difieren en algo de los criterios vigentes en la actualidad del DSM-5.

Fortalezas

Como fortalezas se tienen el diseño muestral del estudio primario con probabilidad de selección hasta el nivel del hogar; la entrevista clínica empleada (CIDI 3.0) la cual permite diagnósticos psiquiátricos y esto da ventaja frente a otros instrumentos que solo permiten tamización de síntomas mentales.

Conclusión

La detección de cohortes específicas con riesgo de sufrir un trastorno mental es un desafío. Este estudio encontró que las personas diagnosticadas con TAB a lo largo de la vida son más vulnerables que otros a sufrir un TUS. Para diversos grupos de personas y profesionales, ser conscientes de esta comorbilidad permitirá brindar información y apoyo, así como un diagnóstico oportuno y el tratamiento para la patología dual. El trastorno oposicionista desafiante gana relevancia como factor asociado con el TAB, lo cual remite a la importancia de factores tempranos del desarrollo infantil como moduladores de psicopatología diagnosticada generalmente en la adultez temprana.

Financiación

No cuentan con ninguna fuente de financiación.

Conflicto de intereses

Los autores no tienen ningún conflicto de intereses para declarar.

BIBLIOGRAFÍA

- McIntyre RS, Berk M, Brietzke E, Goldstein BI, López-Jaramillo C, Kessing LV, et al. Bipolar disorders. *Lancet*. 2020;396(10265):1841–56, [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31544-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31544-0).
- Clemente AS, Diniz BS, Nicolato R, Kapczinski FP, Soares JC, Firmo JO, et al. Bipolar disorder prevalence: a systematic review and meta-analysis of the literature. *Braz J Psychiatry*. 2015;37:155–61, <http://dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2012-1693>.
- Preuss UW, Schaefer M, Born C, Grunze H. Bipolar Disorder and Comorbid Use of Illicit Substances. *Medicina (Kaunas)*. 2021;57:1256.
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5ª ed Condado de Arlington: Editorial Médica Panamericana; 2013. p. 947.
- Vieta E, Berk M, Schulze TG, Carvalho AF, Suppes T, Calabrese JR, et al. Bipolar disorders. *Nat Rev Dis Primers*. 2018;8:18008, <http://dx.doi.org/10.1038/nrdp.2018.8>.
- Belmaker RH. Bipolar disorder. *N Engl J Med*. 2004;351:476–86.
- GBD 2016 Alcohol and Drug Use Collaborators. The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Psychiatry*. 2018;5:987–1012.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021 (Bogotá: UNODC-SIMCI, 2022). [Internet], [consultado 30 May 2023]. Disponible en: <https://www.unodc.org/colombia/es/el-cultivo-de-coca-alcanzo-niveles-historicos-en-colombia-con-204-000-hectareas-registradas-en-2021.html>
- Organización Panamericana de la Salud. Abuso de sustancias. [Internet], [consultado 30 May 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias>
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders*. 4th ed Washington, D.C.: APA; 1994. p. 873.
- Karila L, Petit A, Lowenstein W, Reynaud M. Diagnosis and consequences of cocaine addiction. *Curr Med Chem*. 2012;19:5612–8.
- González-Pinto A, Goikolea JM, Zorrilla I, Bernardo M, Arrojo M, Cunill R, et al. Guía de práctica clínica para el tratamiento farmacológico y psicológico de los pacientes adultos con trastorno bipolar y un diagnóstico comórbido de trastorno por uso de sustancias. *Adicciones*. 2022;34:142–56.
- Salloum IM, Brown ES. Management of comorbid bipolar disorder and substance use disorders. *Am J Drug Alcohol Abuse*. 2017;43:366–76.
- Pettinati HM, O'Brien CP, Dundon WD. Current status of co-occurring mood and substance use disorders: a new therapeutic target. *Am J Psychiatry*. 2013;170:23–30, <http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.12010112>.
- Conway KP, Compton W, Stinson FS, Grant BF. Lifetime comorbidity of DSM-IV mood and anxiety disorders and specific drug use disorders: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. *J Clin Psychiatry*. 2006;67:247–57, <http://dx.doi.org/10.4088/JCP.v67n0211>.
- Torres de Galvis Y, Restrepo-Bernal D, Castaño-Pérez G, Sierra-Hincapié GM, Buitrago-Salazar C, Salas-Zapata C, et al. Estudio poblacional de salud mental, Envigado 2017. Editorial CES. 2018. Disponible en: <https://repository.ces.edu.co/handle/10946/3788?show=full>
- Toftdahl NG, Nordentoft M, Hjorthøj C. Prevalence of substance use disorders in psychiatric patients: a nationwide Danish population-based study. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2016;51:129–40.
- Hasin DS, Stinson FS, Ogburn E, Grant BF. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV alcohol abuse and dependence in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. *Arch Gen Psychiatry*. 2007;64:830–42.
- Hossain S, Mainali P, Bhimanadham NN, Imran S, Ahmad N, Patel RS. Medical and Psychiatric Comorbidities in Bipolar Disorder: Insights from National Inpatient Population-based study. *Cureus*. 2019;11:e5636.
- Hunt GE, Malhi GS, Cleary M, Lai HMX, Sitharthan T. Comorbidity of bipolar and substance use disorders in national surveys of general populations, 1990–2015 Systematic review and meta-analysis. *J Affect Disorder*. 2016;206:321–30.
- Yatham LN, Kauer-Sant'Anna M, Bond DJ, Lam RW, Torres I. Course and outcome after the first manic episode in patients

- with bipolar disorder: prospective 12-month data from the systematic treatment optimization program for early mania project. *Can J Psychiatry*. 2009;54:105–12, 5.
22. Frank E, Boland E, Novick DM, Bizzarri JV, Rucci P. Association between illicit drug and alcohol use and first manic episode. *Pharmacol Biochem Behav*. 2007;86:395–440, 5.
 23. Bauer MS, Altshuler L, Evans DR, Beresford T, Williford WO, Hauger R. Prevalence and distinct correlates of anxiety, substance, and combined comorbidity in a multi-site public sector sample with bipolar disorder. *J Affect Disord*. 2005;85:301–15.
 24. Nallet A, Weber B, Favre S, Gex-Fabry M, Voide R, Ferrero F, et al. Screening for bipolar disorder among outpatients with substance use disorders. *Eur Psychiatry*. 2013;28:147–53.
 25. van Zaane J, van den Berg B, Draisma S, Nolen WA, van den Brink W. Screening for bipolar disorders in patients with alcohol or substance use disorders: performance of the mood disorder questionnaire. *Drug Alcohol Depend*. 2021;124:235–41.
 26. Gold AK, Otto MW, Deckersbach T, Sylvia LG, Nierenberg AA, Kinrys G. Substance use comorbidity in bipolar disorder: a qualitative review of treatment strategies and outcomes. *Am J Addict*. 2018;27:188–201.
 27. Arias F, Szerman N, Vega P, Mesías B, Basurte I, Rentero D. Trastorno bipolar y trastorno por uso de sustancias Estudio Madrid sobre prevalencia de patología dual. *Adicciones*. 2017;29:186–94.
 28. Merikangas KR, Akiskal HS, Angst J, Greenberg PE, Hirschfeld RM, Petukhova M, et al. Lifetime and 12-month prevalence of bipolar spectrum disorders in the National Comorbidity Survey replication. *Arch Gen Psychiatry*. 2007;64: 543–52.
 29. Couillard-Larocque M, Fortin-Vidah G, Angers M, Garceau L, Gros L, Fourné I, et al. Anxiety in bipolar disorder: A review of publication trends. *J Affect Disord*. 2023;320:340–7.
 30. Krishan KRR. Psychiatric and medical comorbidities of bipolar disorder. *Psychosom Med*. 2005;6:1–8.
 31. Vázquez GH, Baldessarini RJ, Tondo L. Co-occurrence of anxiety and bipolar disorders: clinical and therapeutic overview. *Depress Anxiety*. 2014;31:196–206.
 32. Spoorthy MS, Chakrabarti S, Grover S. Comorbidity of bipolar and anxiety disorders: An overview of trends in research. *World J Psychiatry*. 2019;9:7–29.
 33. Schiweck C, Arteaga-Henriquez G, Aichholzer M, Thanarajah SE, Vargas-Cáceres S, Matura S, et al. Comorbidity of ADHD and adult bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev*. 2021;124:100–23.
 34. Biederman J, Petty CR, Dolan C, Hughes S, Mick E, Monuteaux MC, et al. The long-term longitudinal course of oppositional defiant disorder and conduct disorder in ADHD boys: findings from a controlled 10-year prospective longitudinal follow-up study. *Psychol Med*. 2008;38:1027–36.
 35. Biederman J, Mick E, Wozniak J, Monuteaux MC, Galdo M, Faraone SV. Can a subtype of conduct disorder linked to bipolar disorder be identified? Integration of findings from the Massachusetts General Hospital Pediatric Psychopharmacology Research Program. *Biol Psychiatry*. 2003;53:952–60.
 36. Wozniak J, Wilens T, DiSalvo M, Farrel A, Wolenski R, Faraone SV, et al. Comorbidity of Bipolar I Disorder and Conduct Disorder: A Familiar Risk Analysis. *Acta Psychiatr Scand*. 2019;139:361–8, <http://dx.doi.org/10.1111/acps.13013>.
 37. Post RM, Altshuler LL, Kupka R, McElroy SL, Frye MA, Rowe M, et al. Verbal abuse, like physical and sexual abuse, in childhood is associated with an earlier onset and more difficult course of bipolar disorder. *Bipolar Disord*. 2015;17:323–30.
 38. Etain B, Aas M, Andreassen OA, Lorentzen S, Dieset I, Gard S, et al. Childhood trauma is associated with severe clinical characteristics of bipolar disorders. *J Clin Psychiatry*. 2013;74:991–8.
 39. Miller JN, Black DW. Bipolar disorder and suicide: a review. *Curr Psychiatry Rep*. 2020;22:6.
 40. Beyer JL, Weisler RH. Suicide behaviors in bipolar disorder: a review and update for the clinician. *Psychiatr Clin North Am*. 2016;39:111–23.
 41. Rossom RC, Yarborough BJ, Boggs JM, Coleman KJ, Ahmedani BK, Lynch FL, et al. Prediction of suicidal behavior using self-reported suicidal ideation among patients with bipolar disorder. *J Affect Disord*. 2021;295:410–5.